EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 84220
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-05-09 12:05:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: CRISTIAN OMAR ORREGO ARANCIBIA			RUN	: 16.976.896-K
F.Nac	: 08-08-1988	Edad	: 35 AÑOS, 9 MESES	Género	: Masculino
Dirección	: SAN CAMILO KM 1			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 939565527		
Fecha Ingreso	: 2024-05-07	Fecha Egreso	: 2024-05-09 12:05:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. C46-SARCOMA DE KAPOSI

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1. Sarcoma de kaposi
-->Biopsia cutanea confirmada
-->Biopsia gastrica pendiente
2. Micobacteriosis atipica
3. Linfoadenopatias retroperitoneales - mesentericas e iliacas
--> Obs. sindrome linfoproliferativo vs compromiso visceral de kaposi
4. Bicitopenia en estudio
--> Anemia severa hipocromica - microcitica transfundida
--> Linfopenia
5. VIH C3 en TARV
--> Etapa SIDA
--> CD4 636
6. Desnutricion calorico-proteico severa
-->IMC 16.5
7. hipoalbuminemia

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. C46.0-SARCOMA DE KAPOSI DE LA PIEL (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)
2. A31-INFECCIONES DEBIDAS A OTRAS MICOBACTERIAS (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
3. D50-D53-ANEMIAS NUTRICIONALES (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
4. B20-B24-ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICENCIA HUMANA (VIH) (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
5. E43.X-DESNUTRICION PROTEICOCALORICA SEVERA,NO ESPECIFICADA. (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
6. R77.0-ANORMALIDAD DE LA ALBUMINA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

paciente masculino de 35 años con antecedentes de VIH en etapa SIDA en tratamiento con TLD (tenofovir (TDF), lamivudina y dolutegravir) + Dolutegravir , con tratamiento previo de TBC intestinal descartado por broncopulmonar, quien el dia 04/04 ajusta esquema de continuacion por 12 meses , hospitalizaciones recientes en HSC, trasladado desde HCHM Chillan el dia 08/05. ingresa a HCHM por cuadro de dolor abdominal de 1 semana de evolucion con diarrea intermitente y vomitos, TAC AP reporta multiples imagenes nodulares pulmonares, en retroperitoneo y mesenterio extendiendose a cadenas iliacas bilaterales. estudiado por comite TARV en HCHM, donde se realiza biopsia ganglionar el dia 26/04 , genexpert y inmunofenotipo en contexto de sindrome linfoproliferativo y kaposi visceral. Evaluado por dermatologia quien realiza biopsia de lesiones cutaneas que informan Sarcoma de Kaposi. en espera de resultado de biopsias para evaluar compromiso visceral. Durante hospitalizacion previa paciente requirió transfusión de 1 U de GR, EDA el 29/04: Gastropatia congestiva severa en cuerpo gastrico con lesion ulcerada que impresiona Kaposi gastrico biopsia aun

pendiente. Tras informe de Kaposi y TAC con imagenes nodulares viscerales, oncologia HCHM toma cocimiento de caso,solicitando genexpert Tb + inmunofenotipo, en contexto de descartar linfoma, y además evaluar si corresponde a Kaposi con compromiso visceral, solicita presentar a comite oncologico con resultado de biopsia gastrica y ganglionar para inicio de QT. Paciente es derivado a HSC el dia 08/05 en contexto de manejo nutricional y esperar resultados, sin inestabilidad desde el punto de vista medico, con VIH con recuento CD4 636, nutricionalmente comprometido, evaluado previamente por nutriologa, quien deja carga semanal de vit D por 6 semanas. reevaluado por nutricion de HSC quien realiza evaluacion determinando peso actual de 43 kg con IMC 16.3 kg/m2, con una desnutricion calorico proteica severa e hipoalbuminemia, se realiza ajuste de regimen, y se deja suplementacion dado buena disponibilidad y tolerancia, se deja certificado para retirar suplementacion via oral de paciente de forma ambulatoria, indicando formula polimerica 230cc 2 veces cada dia + educacion de regimen hiperproteico a paciente. Paciente durante hospitalizacion actualmente estable, hemodinamia sin conflicto, autosostenida, normotenso, eucardico, eupneico, se mantiene afebril, sin requerimientos de o2 suplementario, diuresis presente, buena tolerancia a la via oral, sin dolor, disnea, nauseas, vomitos u otro sintoma. manteniendo TARV y tratamiento medico ajustado por oncologia, en espera de resultado de biopsia de ganglios linfaticos de cadena inguinal izquierda, con aposito in situ, herida de cuidado, aun requiere curaciones diarias, sin requerimientos de terapia endovenosa, dado lo anterior, se decide alta medica a hospitalizacion domiciliaria con ajuste de terapia nutricional ya indicada, y revision en 7 dias con derivacion de resultado de biopsia.

PLAN DE MANEJO:

-Paciente trasladado desde HCHM Chillan, con diagnosticos conocidos, con resultado de biopsia aun pendientes en contexto de posible sindrome linfoproliferativo, y compromiso visceral de Kaposi que ameritaria inicio de quimioterapia y ajuste de tratamiento segun oncologia.
-Ingresa en condiciones de cuidado desde el aspecto nutricional, evaluado por equipo de nutricion quien evalua a paciente con IMC de 16.3 kg/m2 y suplementa a paciente con regimen hipercalorico hiperproteico suplementado en domicilio, se deja certificado de suplementacion con formula polimerica para retirar al alta + educacion en regimen a paciente.
-Mantener TARV + resto de terapia ajustada, en espera de resultado de biopsia de adenopatias de cadena inguinal izquierda, paciente sin inestabilidad hemodinamica, VIH con recuento CD4 bajo, sin requerimientos de terapia endovenosa, con buena tolerancia oral, deambulacion presente , se decide alta medica a hospitalizacion domiciliaria dado que aun persiste zona de biopsia con requerimientos de curaciones diarias, + suplementacion nutricional, se solicita revision de resultados de biopsia via GES el dia lunes para eventualmente informar a comite oncologico de HCHM

INDICACIONES AL ALTA

1. -Reposo Relativo Asistido en HODOM
2. -Régimen Oral hipercalorico hiperproteico Suplementado, según indicaciones de nutricion
3. -TARV: TLD 1 comp 8 am - Dolutegravir 8 pm
4. -Cotrimoxazol forte 1 comp al dia VO
5. -Levofloxacino 1000 mg/dia VO x 12m
6. -Claritromicina 500 mg cada 12h VO x 12m
7. -Etambutol 800 mg/dia VO x 12m
8. -Paracetamol 1g c/8 hrs x VO SOS
9. -Omeprazol 20 mg dia VO (30 min antes del desayuno)
10. -Ferrovitaminico 1 comprimido cada 12 h VO
11. -Vitamina D 50.000 UI/semanal VO por 6 semanas
12. -Quetiapina 25 mg/noche VO SOS
13. -Curacion diaria de zona inguinal, por HODOM
14. -Pendiente resultado de Biopsia tomada en EDA, y resultado de biopsia ganglionar.
15. -Revisar biopsia el dia lunes por GES

EXÁMENES Y RESULTADOS

Evaluacion nutricional: Desnutricion calorico proteica severa, IMC 16,3

Control en: 7 días en HOSPITAL DE SAN CARLOS

Jorge Andres Villa Flores

JEFE SERVICIO

MEDICO TRATANTE
16178692-6